

Le Professioni Bio-Psico-Sociali

Volume 3 — Operatore in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)

*Tre figure professionali distinte sotto un'unica cornice nazionale,
un'evidenza Cochrane cauta sulla demenza, e un dovere di tutela del
benessere animale senza precedenti nella collana*

Luigi De Michele

luglio 2026

Nota editoriale

Questo Volume tratta gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), terza figura del censimento pianificato della collana «Le Professioni Bio-Psico-Sociali». A differenza del Counselor (Volume 1) e del Mediatore Familiare (Volume 2), qui non si tratta di un'unica figura professionale ma di tre ruoli distinti disciplinati da un'unica cornice nazionale, l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015: il responsabile di progetto/referente di intervento, il coadiutore dell'animale, e il veterinario esperto in benessere animale. Questo Volume tratta i tre ruoli congiuntamente, riflettendo la struttura della normativa di riferimento, e segnala questa scelta come una particolarità metodologica rispetto ai Volumi precedenti. Questo Volume dichiara inoltre le seguenti lacune informative: non è stato possibile consultare direttamente il testo integrale dell'Accordo Stato-Regioni del 2015 né i rapporti annuali del Centro di Riferenza Nazionale IAA, per un blocco tecnico sistematico dello strumento di recupero diretto delle pagine web riscontrato su gran parte dei domini istituzionali testati in questa tranche di ricerca; nessun conteggio nazionale certificato di operatori o strutture accreditate è stato reperito; un'ipotesi iniziale della ricerca relativa a un ente denominato «SIAA» come corpo di formazione collegato a Fondazione San Patrignano non ha trovato riscontro verificabile e non è stata inclusa nel Volume; l'esistenza e l'esatto ambito di una norma tecnica UNI specificamente dedicata alle figure IAA non è stata confermata, e la norma UNI 11790:2020, relativa agli esperti cinofili, è riportata come riferimento affine ma non identico, con relazione non verificata rispetto alle figure IAA. Per la parte di sovrapposizione funzionale con figure sanitarie e sociali già censite nella collana madre, in particolare laddove il responsabile di progetto TAA sia un medico o uno psicologo, questo Volume rinvia all'opera madre «Psicologo di Base» e ai Volumi pertinenti della collana gemella «Le Professioni di Base», senza duplicarne la valutazione.

Dashboard

Indicatore	Valore	Fonte
Inquadramento normativo	Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015 (Atti n. 60/CSR), Linee guida nazionali IAA; tre sottotipi di intervento (TAA terapeutico, EAA educativo, AAA ricreativo-socializzante) e tre figure professionali (responsabile di progetto/referente di intervento, coadiutore dell'animale, veterinario esperto)	Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015; DPCM 28 febbraio 2003 (quadro previgente)
Attuazione regionale	Fortemente disomogenea: il Lazio disciplina la materia dal 2016 (Determinazione G11110/2016), il Veneto solo dal 10 giugno 2024 (DGR 655/2024); portale nazionale Digital Pet (IZSve/CRN IAA) come registro di riferimento, senza un conteggio nazionale certificato di operatori o strutture	Regione Lazio; Regione Veneto; IZSve — Digital Pet
Popolazione di operatori e strutture	Nessun conteggio nazionale certificato reperito; fonti convergenti su una carenza persistente di veterinari, referenti di intervento TAA e strutture accreditate rispetto alla domanda	ANMVI, «IAA, ancora pochi Veterinari e poche strutture»; ISS
Evidenza di efficacia (demenza)	Revisione Cochrane 2019 (9 RCT, 305 partecipanti): possibile lieve riduzione dei	Lai et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, CD013243

Indicatore	Valore	Fonte
	sintomi depressivi (evidenza di qualità bassa), nessun miglioramento della qualità della vita (evidenza di qualità moderata), nessuna differenza chiara su funzionamento sociale, comportamento problematico o agitazione; conclusioni definitive non ancora possibili	
Finanziamento pubblico documentato	Emilia-Romagna: primo bando regionale dedicato, 299.111,12 euro complessivi, 31 progetti finanziati per categorie fragili (DGR 622/2024, art. 15 L.R. 18/2023); nessun dato di costo-efficacia italiano o internazionale reperito rispetto alla cura standard	Regione Emilia-Romagna, DGR 622/2024

Executive summary

Gli Interventi Assistiti con gli Animali rappresentano, nella collana «Le Professioni Bio-Psico-Sociali», il primo caso di una cornice normativa che disciplina non una singola figura professionale ma tre ruoli distinti e complementari — il responsabile di progetto o referente di intervento, il coadiutore dell'animale, e il veterinario esperto in benessere animale — attorno a un percorso formativo comune strutturato in un corso propedeutico, un corso base e un corso avanzato. L'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 costituisce oggi il riferimento nazionale, ma la sua attuazione regionale risulta fortemente disomogenea: alcune Regioni, come il Lazio, disciplinano la materia con proprio atto dal 2016, mentre altre, come il Veneto, lo hanno fatto solo nel giugno 2024, quasi un decennio più tardi. Sul piano dell'evidenza di efficacia, questo Volume può fondarsi su un dato raro nella collana finora: l'esistenza di una revisione sistematica Cochrane, relativa all'uso della terapia assistita con animali nella demenza, che tuttavia giunge a una conclusione cauta e non definitiva, con un'evidenza di qualità bassa o molto bassa sulla maggior parte degli esiti misurati. Per altre popolazioni target — disturbo dello

spettro autistico, disturbo da stress post-traumatico, depressione — non esiste alcuna revisione Cochrane, e la letteratura disponibile è di qualità metodologica inferiore. Una dimensione specifica e assente nelle altre figure di questa collana è il dovere di tutela del benessere animale, codificato dall'Accordo del 2015 attraverso il monitoraggio continuo delle condizioni dell'animale, il ruolo di garanzia del veterinario nella determinazione della frequenza delle sessioni, e l'obbligo di garantire condizioni di vita adeguate agli animali «pensionati» dall'attività.

Cinque risultati chiave

1. L'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 disciplina tre figure professionali distinte e complementari, non una figura singola: il responsabile di progetto/referente di intervento, il coadiutore dell'animale, il veterinario esperto in benessere animale, ciascuna con un proprio percorso di qualificazione.
2. L'attuazione regionale della normativa nazionale è fortemente disomogenea: il Lazio ha adottato un proprio atto disciplinare già nel 2016, il Veneto solo nel giugno 2024, con quasi un decennio di scarto tra Regioni.
3. L'unica revisione sistematica Cochrane individuata in questo dominio, relativa alla demenza, riporta un'evidenza di qualità bassa o molto bassa sulla maggior parte degli esiti misurati, e conclude esplicitamente che «conclusioni definitive non possono ancora essere tratte» sui benefici e rischi complessivi della terapia assistita con animali in questa popolazione: un'evidenza che questo Volume riporta senza addolcirla.
4. Per le popolazioni con disturbo dello spettro autistico, disturbo da stress post-traumatico e depressione, non esiste alcuna revisione Cochrane: la letteratura disponibile è di qualità metodologica dichiaratamente inferiore, e per il disturbo da stress post-traumatico una rassegna dedicata non ha individuato alcuno studio randomizzato controllato specifico sulla terapia assistita da cani.
5. L'Accordo Stato-Regioni del 2015 codifica un dovere di tutela del benessere animale assente nelle altre figure di questa collana — monitoraggio continuo, gatekeeping veterinario sulla frequenza delle sessioni, obbligo di condizioni di vita adeguate per gli animali «pensionati» — che la stessa revisione Cochrane sulla demenza segnala di non aver mai misurato in nessuno dei nove studi randomizzati controllati inclusi.

Raccomandazioni

1. Promuovere l'armonizzazione dell'attuazione regionale dell'Accordo Stato-Regioni 2015, oggi frammentata su un arco temporale di quasi un decennio tra le Regioni più e meno tempestive.
2. Sostenere la produzione di studi randomizzati controllati di qualità metodologica più elevata per le popolazioni con disturbo dello spettro autistico,

disturbo da stress post-traumatico e depressione, oggi prive di una revisione Cochrane dedicata.

3. Introdurre sistematicamente, negli studi futuri di efficacia degli Interventi Assistiti con gli Animali, misure degli esiti sul benessere dell'animale coinvolto, oggi assenti nella totalità degli studi randomizzati controllati inclusi nella revisione Cochrane sulla demenza.

Capitolo 1. Inquadramento normativo e professionale

Un accordo nazionale, tre figure professionali

Gli Interventi Assistiti con gli Animali sono disciplinati in Italia dall'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 (Atti n. 60/CSR), recante le Linee guida nazionali per gli IAA, che ha sostituito il quadro previgente fondato sul DPCM 28 febbraio 2003.¹ L'Accordo distingue tre sottotipi di intervento: la Terapia Assistita con gli Animali (TAA), rivolta al trattamento di disturbi della sfera fisica, neuromotoria o psichica; l'Educazione Assistita con gli Animali (EAA), rivolta a promuovere e sostenere le risorse di crescita individuale, la progettualità, la relazione e l'integrazione sociale; l'Attività Assistita con gli Animali (AAA), di natura ricreativa e di socializzazione.²

L'Accordo individua inoltre tre figure professionali distinte, ciascuna con un proprio percorso di qualificazione: il responsabile di progetto e il referente di intervento, la cui qualificazione richiesta varia a seconda che l'intervento sia di tipo TAA (laurea in medicina o in psicologia con specializzazione in psicoterapia per il responsabile di progetto; qualifiche delle professioni sanitarie per il referente di intervento) o di tipo EAA (laurea in pedagogia, psicologia o altre discipline educative); il coadiutore dell'animale, che accompagna e gestisce l'animale durante le sessioni e non richiede una laurea, accedendo tramite il percorso formativo descritto al paragrafo successivo; il veterinario esperto in benessere animale, che deve possedere la laurea in medicina veterinaria oltre alla formazione specifica.³

Il percorso formativo comune

Il percorso di formazione per le tre figure si articola, secondo quanto riportato da più enti di formazione che dichiarano di operare in conformità all'Accordo del 2015, in un corso propedeutico comune di almeno 21 ore, un corso base differenziato per figura professionale e specie animale coinvolta, e un corso avanzato di almeno 120 ore, comprensivo di lezioni frontali, tirocinio pratico e visite guidate, da completarsi entro un termine massimo di quattro anni dal corso propedeutico.⁴ Questo Volume non ha potuto verificare questi dati orari consultando il testo integrale dell'Accordo, e li riporta come convergenti tra più fonti secondarie indipendenti, non come dato di fonte primaria confermato.

Questo Volume segnala inoltre che l'ipotesi iniziale della propria ricerca, relativa all'esistenza di un ente denominato «SIAA» quale corpo di formazione collegato a

¹Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015 (Atti n. 60/CSR), «Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)»; DPCM 28 febbraio 2003, quadro previgente sul benessere degli animali d'affezione e sulla cosiddetta pet therapy.

²Definizione dei tre sottotipi di intervento — TAA, EAA, AAA — secondo l'Accordo Stato-Regioni 2015, come riportata da fonti regionali (Regione Emilia-Romagna) e dall'Istituto Superiore di Sanità.

³Requisiti di qualificazione delle tre figure professionali IAA (responsabile di progetto/referente di intervento, coadiutore dell'animale, veterinario esperto), come riportati da enti di formazione dichiaratamente conformi all'Accordo Stato-Regioni 2015.

⁴Struttura del percorso formativo (corso propedeutico ≥21 ore, corso base, corso avanzato ≥120 ore, termine massimo di quattro anni), come riportata da più enti di formazione professionale.

Fondazione San Patrignano, non ha trovato riscontro verificabile in questa tranche e non viene pertanto ripresa nel corpo del Volume. È stata invece confermata l'esistenza della norma tecnica UNI 11790:2020, relativa agli esperti cinofili, la cui relazione esatta con le figure IAA disciplinate dall'Accordo del 2015 non è stata verificata in questa tranche di ricerca e viene riportata come riferimento affine, non come norma tecnica specificamente dedicata alle figure IAA.⁵

Capitolo 2. Bisogno di salute bio-psico-sociale

Contesti di utilizzo e assenza di un dato nazionale di utilizzo

Gli Interventi Assistiti con gli Animali sono utilizzati in Italia in una pluralità di contesti: strutture ospedaliere, residenze sanitarie assistenziali, scuole, fattorie sociali ed educative, e — un dato meno atteso ma documentato da fonti giornalistiche convergenti — istituti penitenziari, con programmi attivi in Toscana (Pisa, Livorno, Lucca, Volterra, San Gimignano, Gorgona), Puglia (Taranto, dal febbraio 2024) e Lombardia (Cremona).⁶ L'Istituto Superiore di Sanità osserva, in una propria pagina istituzionale, che «nonostante l'ampio numero di programmi di IAA esistenti sul territorio nazionale, la maggior parte di essi manca di una solida struttura metodologica e si fonda su valutazioni descrittive piuttosto che su valutazioni fondate su ipotesi, obiettivi e misurazioni quantitative».⁷ Questo Volume non ha reperito, in questa tranche di ricerca, un dato ISS o del Centro di Riferenza Nazionale IAA sul numero complessivo di beneficiari a livello nazionale, e riporta questa affermazione dell'ISS come la caratterizzazione più autorevole disponibile del bisogno, pur non quantificata.

Capitolo 3. Modello «Operatore IAA di Base»

Un'attuazione regionale disomogenea su quasi un decennio

L'attuazione regionale dell'Accordo Stato-Regioni del 2015 risulta fortemente disomogenea nei tempi. Il Lazio ha adottato un proprio atto disciplinare, la Determinazione n. G11110, già il 3 ottobre 2016, con un registro regionale delle figure professionali IAA periodicamente aggiornato.⁸ Il Veneto ha invece disciplinato formalmente i percorsi formativi solo con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 10 giugno 2024, quasi otto anni più tardi. Altre Regioni, tra cui

⁵UNI 11790:2020, norma tecnica relativa agli esperti cinofili; relazione con le figure IAA disciplinate dall'Accordo Stato-Regioni 2015 non verificata da questo Volume.

⁶Programmi di Interventi Assistiti con gli Animali in ambito penitenziario: Fondazione Don Bosco e associazione Do Re Miao (Toscana: Pisa, Livorno, Lucca, Volterra, San Gimignano, Gorgona); programma per figli di detenuti (Toscana, dal 2018); programma di Taranto (dal febbraio 2024); progetto «Sotto i Ciliegi», Cremona; programma di Massa-Carrara (dal 2023). Fonti giornalistiche: Kodami, Corriere di Taranto, Cremonaoggi, La Nazione.

⁷Istituto Superiore di Sanità, pagina istituzionale sugli Interventi Assistiti con gli Animali: caratterizzazione della debolezza metodologica della maggior parte dei programmi esistenti.

⁸Regione Lazio, Determinazione n. G11110 del 3 ottobre 2016, e relativo registro regionale delle figure professionali IAA; Regione Veneto, Deliberazione della Giunta Regionale n. 655 del 10 giugno 2024.

Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana, mantengono propri registri o elenchi regionali con modalità e tempistiche diverse, e confluiscono, per la parte di operatori e strutture qualificati, nel portale nazionale Digital Pet, gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie in qualità di Centro di Riferenza Nazionale per gli IAA.⁹

Il Centro di Riferenza Nazionale, nelle proprie relazioni annuali, e l'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, in un proprio articolo dal titolo esplicito «IAA, ancora pochi Veterinari e poche strutture», convergono nel segnalare una carenza persistente di professionisti sanitari qualificati come responsabili di progetto o referenti di intervento TAA, e di strutture specializzate accreditate, rispetto alla domanda esistente.¹⁰ Questo Volume non ha potuto consultare direttamente il testo delle relazioni annuali del Centro di Riferenza Nazionale, e riporta questa caratterizzazione della carenza come convergente tra fonti secondarie indipendenti, non come dato numerico verificato.

Capitolo 4. Efficacia ed evidenza di dominio

L'unica revisione Cochrane del dominio: un verdetto cauto sulla demenza

Questo Volume ha individuato, per il dominio degli Interventi Assistiti con gli Animali, un'evidenza sistematica di qualità Cochrane che non è stata reperita per nessuna delle prime due figure di questa collana: la revisione sistematica di Lai e colleghi, pubblicata nel 2019, sulla terapia assistita con animali nella demenza, comprendente nove studi randomizzati controllati per un totale di 305 partecipanti, otto dei quali con cani e uno con cavalli.¹¹ La revisione riporta una possibile lieve riduzione dei sintomi depressivi rispetto all'assenza di intervento (differenza media -2,87; intervallo di confidenza al 95% da -5,24 a -0,50; 2 studi, 83 partecipanti; evidenza di qualità bassa), ma nessun miglioramento della qualità della vita (differenza media 0,45; intervallo di confidenza al 95% da -1,28 a 2,18; 3 studi, 164 partecipanti; evidenza di qualità moderata), e nessuna differenza chiara su funzionamento sociale, comportamento problematico, agitazione o attività della vita quotidiana, con un'evidenza di qualità da bassa a molto bassa su questi ultimi esiti. Nessuno dei nove studi inclusi ha raccolto dati su eventi avversi né su effetti dell'intervento sul benessere degli animali coinvolti. Gli autori concludono testualmente che «conclusioni definitive non possono ancora essere tratte sui benefici e rischi complessivi della terapia assistita con animali nelle

⁹IZSVE (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie), Centro di Riferenza Nazionale per gli IAA, portale Digital Pet (elenco operatori, strutture, progetti, animali idonei); registri regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana.

¹⁰ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), «IAA, ancora pochi Veterinari e poche strutture»; Centro di Riferenza Nazionale IAA, relazioni annuali (contenuto non consultato direttamente da questo Volume).

¹¹Lai N.M., Chang S.M.W., Ng S.S., Tan S.L., Chaiyakunapruk N., Stanaway F., «Animal-assisted therapy for dementia», Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 11, Art. No. CD013243: 9 studi randomizzati controllati, 305 partecipanti; riduzione dei sintomi depressivi di qualità bassa, nessun miglioramento della qualità della vita di qualità moderata, nessuna differenza chiara su altri esiti, nessun dato su eventi avversi o benessere animale.

persone con demenza», ed è questa la conclusione che questo Volume riporta, senza attenuarla.

Per le altre popolazioni target frequentemente associate agli Interventi Assistiti con gli Animali, questo Volume non ha individuato alcuna revisione Cochrane. Per il disturbo dello spettro autistico esiste una rassegna sistematica non Cochrane, condotta su sei studi randomizzati controllati e 300 bambini, che riporta miglioramenti nelle abilità cognitive, comunicative e sociali e una riduzione dell'irritabilità, segnalando tuttavia una qualità metodologica variabile tra gli studi inclusi.¹² Per il disturbo da stress post-traumatico, una rassegna dedicata ha esplicitamente concluso che nessuno studio randomizzato controllato specifico sulla terapia assistita da cani per questa condizione è stato individuato.¹³ Per la depressione, una rassegna sistematica su dodici studi e una meta-analisi più recente riportano un effetto da moderato a statisticamente significativo, in particolare negli anziani, ma nessuna delle due è una revisione Cochrane.¹⁴

Intelligenza artificiale: un'assenza pressoché totale, non una promessa emergente

La ricerca sistematica condotta per questo Volume, inclusa un'interrogazione dedicata della banca dati PubMed che incrocia intelligenza artificiale e monitoraggio degli Interventi Assistiti con gli Animali, non ha individuato alcuno studio pertinente: i risultati restituiti riguardavano ambiti del tutto estranei, quali la somministrazione oculare di farmaci o la diagnostica per immagini polmonare. Questo Volume dichiara pertanto un'assenza pressoché totale di evidenza sull'uso dell'intelligenza artificiale in questo dominio, distinta dalle esperienze preliminari già riscontrate per il Counselor e il Mediatore Familiare nei Volumi precedenti di questa collana. L'unico riferimento italiano individuato è un'associazione, VETeris, che dichiara l'intenzione di esplorare gli effetti degli Interventi Assistiti con gli Animali anche tramite intelligenza artificiale, senza che questo Volume abbia potuto reperire alcuno studio completato o pubblicato in tal senso: si tratta di un'intenzione dichiarata, non di un risultato di ricerca.¹⁵ Applicazioni di intelligenza artificiale al monitoraggio del benessere animale esistono in ambito zootecnico e nella gestione dei canili, ma restano estranee al contesto specifico degli Interventi Assistiti con gli Animali, e questo Volume le richiama come analogie di dominio adiacente, non come evidenza direttamente pertinente.

¹²Rassegna sistematica su disturbo dello spettro autistico: 6 studi randomizzati controllati, 300 bambini, miglioramenti cognitivi/comunicativi/sociali e riduzione dell'irritabilità, qualità metodologica variabile segnalata dagli stessi autori.

¹³Evidence brief del Psychological Health Center of Excellence (2020): nessuno studio randomizzato controllato specifico sulla terapia assistita da cani per il disturbo da stress post-traumatico individuato.

¹⁴Rassegna sistematica su depressione (12 studi, 5 RCT e 7 osservazionali) e meta-analisi più recente con effetto da moderato a statisticamente significativo, in particolare negli anziani; nessuna delle due è una revisione Cochrane.

¹⁵VETeris (associazione italiana): dichiarazione di intenzione di esplorare gli effetti degli Interventi Assistiti con gli Animali anche tramite intelligenza artificiale, senza studi completati reperiti da questo Volume.

Capitolo 5. Valutazione economica

Tabella 5.1 — Doppio ancoraggio economico: finanziamento pubblico regionale documentato e confronto con il costo di formazione

Indicatore	Fonte-cardine di dominio	Fonte di triangolazione
Finanziamento pubblico regionale	Emilia-Romagna: 299.111,12 euro complessivi, 31 progetti finanziati nel primo bando dedicato (DGR 622/2024, art. 15 L.R. 18/2023), media oltre 9.600 euro per progetto	Ripartizione per specie animale: cane in 15 progetti su 31, cavallo in 10, asino in 3, altre specie nei restanti — nessun dato di costo-efficacia associato
Costo di formazione per operatore	Corso base coadiutore cane: circa 800 euro; corso base coadiutore asino: circa 1.000 euro (fonti di mercato di un singolo ente, non ufficiali)	Nessun dato nazionale ufficiale sul costo complessivo del percorso propedeutico più corso avanzato; cifra non generalizzabile a un costo medio nazionale
Costo-efficacia rispetto alla cura standard	Nessuno studio italiano reperito	Un solo studio internazionale pertinente reperito (Stati Uniti, veterani con disturbo da stress post-traumatico) confronta cani di servizio e cani di supporto emotivo tra loro, non l'intervento assistito dagli animali rispetto all'assenza di intervento, e non rileva differenze significative di costo sanitario complessivo a 18 mesi

L'Emilia-Romagna costituisce, per quanto reperito in questa tranche di ricerca, il dato di finanziamento pubblico più solido e tracciabile a una fonte ufficiale regionale (BURERT) individuato per questa figura in tutta la collana finora. Nessuno studio di costo-efficacia dell'intervento assistito dagli animali rispetto alla cura standard, italiano o internazionale, è stato reperito: una lacuna che questo Volume considera particolarmente rilevante per un dominio a impostazione di Health Technology Assessment.

Capitolo 6. Modellazione e incertezza

Un'incertezza cumulata su normazione, popolazione ed evidenza

L'assenza di un conteggio nazionale certificato di operatori e strutture accreditate, l'assenza di un dato nazionale di utilizzo per popolazione target, e l'assenza di qualunque studio di costo-efficacia italiano o internazionale rispetto alla cura standard impediscono, in questa tranche, la costruzione di un'analisi di sensibilità deterministica, di un'analisi di sensibilità probabilistica, di un'analisi di scenario o

di una curva di accettabilità costo-efficacia. Il dato di finanziamento pubblico dell'Emilia-Romagna, per quanto solido, riguarda una singola Regione e un singolo anno, e non è generalizzabile a un modello nazionale.

Capitolo 7. Equità e impatto distributivo

Un accesso segnato da un divario regionale di quasi un decennio

Il divario temporale tra le Regioni che hanno disciplinato tempestivamente la materia — il Lazio dal 2016 — e quelle che lo hanno fatto solo di recente — il Veneto dal 2024 — costituisce un elemento di disomogeneità distributiva particolarmente marcato rispetto alle altre figure di questa collana, in cui la frammentazione regionale riguardava tipicamente il finanziamento e non la stessa esistenza di un quadro regolatorio applicativo. Questo Volume non ha reperito un dato sistematico sulla distribuzione geografica delle strutture accreditate o degli operatori qualificati che consenta di quantificare l'impatto di questo divario sull'accesso effettivo, e si astiene dal formulare un giudizio di priorità territoriale non tracciabile a un dato sistematico.

Capitolo 8. Profili etico-giuridico-organizzativi e percorso normativo

Una cronologia normativa dal 2003 al 2024

Il percorso normativo può essere ricostruito come segue: il DPCM 28 febbraio 2003 istituisce il primo quadro nazionale sul benessere degli animali d'affezione e sulla cosiddetta pet therapy; l'Accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015 sostituisce tale quadro con le attuali Linee guida nazionali IAA, definendo i tre sottotipi di intervento e le tre figure professionali; il Lazio adotta un proprio atto disciplinare di attuazione regionale nell'ottobre 2016; l'attuazione regionale prosegue in modo disomogeneo negli anni successivi, fino al Veneto che vi provvede solo nel giugno 2024; la norma tecnica UNI 11790:2020, relativa agli esperti cinofili, viene pubblicata con una relazione rispetto alle figure IAA non verificata da questo Volume.

Un elemento specifico di questa figura, assente nelle altre trattate finora dalla collana, è il dovere di tutela del benessere dell'animale coinvolto, codificato dall'Accordo del 2015 attraverso tre meccanismi convergenti: il monitoraggio clinico e comportamentale continuo dell'animale, sia durante le sessioni sia nei periodi di inattività; il ruolo di garanzia del veterinario esperto, che sulla base di tale monitoraggio determina la frequenza massima delle sessioni e le modalità di impiego di ciascun animale; l'obbligo di garantire condizioni di vita adeguate agli animali che, per età o condizioni di salute, vengono «pensionati» dall'attività.¹⁶

¹⁶Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015: disposizioni sul monitoraggio clinico e comportamentale continuo dell'animale, sul ruolo di garanzia del veterinario nella determinazione della frequenza delle sessioni, e sull'obbligo di condizioni di vita adeguate per gli animali «pensionati», come

Questo Volume segnala che tale impianto di tutela, per quanto codificato a livello normativo, non trova alcun riscontro nella letteratura di efficacia clinica esaminata al Capitolo 4: nessuno dei nove studi randomizzati controllati inclusi nella revisione Cochrane sulla demenza ha raccolto dati sugli effetti dell'intervento sul benessere dell'animale coinvolto, un'asimmetria che questo Volume considera un risultato rilevante in sé.

Capitolo 9. Verdetto tripartito e raccomandazioni

Verdetto fiscale

In assenza di un dato di costo pubblico nazionale sistematico e di qualunque studio di costo-efficacia rispetto alla cura standard, non è possibile in questa tranche formulare un verdetto fiscale quantificato su base nazionale. Il dato di finanziamento pubblico dell'Emilia-Romagna, pur solido e tracciabile a fonte ufficiale, documenta un impegno di spesa regionale circoscritto e non generalizzabile.

Verdetto sanitario

Il verdetto sanitario di questo Volume è condizionato dalla stessa cautela espressa dalla revisione Cochrane 2019 sulla demenza, l'unica revisione sistematica Cochrane individuata nell'intero dominio: un'evidenza di qualità bassa o molto bassa sulla maggior parte degli esiti misurati, e una conclusione esplicita secondo cui non è ancora possibile formulare un giudizio definitivo sui benefici e rischi complessivi. Per le altre popolazioni target — disturbo dello spettro autistico, disturbo da stress post-traumatico, depressione — l'assenza di una revisione Cochrane dedicata impone una cautela ulteriore. Questo Volume giudica pertanto il modello «Operatore IAA di Base» come potenzialmente favorevole ma non ancora validato con il livello di certezza raggiunto da altri interventi sanitari consolidati, in una condizione di prudenza evidenziale che va mantenuta esplicita.

Verdetto sociale

Il verdetto sociale è condizionato dal marcato divario temporale nell'attuazione regionale, che ha lasciato alcune Regioni prive di un quadro applicativo per quasi un decennio rispetto ad altre, e dalla carenza documentata di professionisti qualificati e strutture accreditate rispetto alla domanda esistente. A questi elementi si aggiunge una dimensione specifica di questa figura: il dovere di tutela del benessere animale, che pur codificato a livello normativo resta privo di qualunque riscontro nella letteratura di efficacia esaminata, un'asimmetria che questo Volume considera rilevante per una valutazione bio-psico-sociale che intenda includere, coerentemente con l'oggetto stesso dell'intervento, anche il benessere del soggetto animale coinvolto.

riportate da fonti regionali e di settore (Umanimalmente, ASL Roma 4).

Appendici registrate

Appendice A. Fonti

Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015 (Atti n. 60/CSR); DPCM 28 febbraio 2003; UNI 11790:2020; Regione Lazio, Determinazione n. G11110/2016; Regione Veneto, DGR n. 655/2024; Regione Emilia-Romagna, DGR 622/2024 e L.R. 18/2023; IZSve — Centro di Referenza Nazionale IAA e portale Digital Pet; ANMVI, «IAA, ancora pochi Veterinari e poche strutture»; ISS; Lai N.M. et al., Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, CD013243; rassegna sistematica su disturbo dello spettro autistico (6 RCT, 300 bambini); evidence brief su disturbo da stress post-traumatico; rassegna sistematica e meta-analisi su depressione; VETeris; fonti giornalistiche sui programmi IAA in ambito penitenziario (Toscana, Puglia, Lombardia). Ricerca condotta tramite motore di ricerca generale e banca dati PubMed, con blocco tecnico sistematico dello strumento di recupero diretto delle pagine web riscontrato su gran parte dei domini istituzionali testati.

Appendice B. Glossario

TAA (Terapia Assistita con gli Animali): intervento a finalità terapeutica/riabilitativa. EAA (Educazione Assistita con gli Animali): intervento a finalità educativa e di sostegno alla crescita individuale. AAA (Attività Assistita con gli Animali): intervento a finalità ricreativa e di socializzazione. Responsabile di progetto/referente di intervento: figura sanitaria, psicologica o pedagogica che progetta e conduce l'intervento IAA. Coadiutore dell'animale: figura che gestisce l'animale durante le sessioni. Veterinario esperto in benessere animale: figura che valuta l'idoneità sanitaria e comportamentale dell'animale e ne determina la frequenza di impiego. Digital Pet: portale nazionale di riferimento per operatori, strutture e progetti IAA, gestito dall'IZSve.

Appendice C. Mappatura comparata

A differenza del Counselor (Volume 1) e del Mediatore Familiare (Volume 2), gli Interventi Assistiti con gli Animali sono disciplinati da un'unica cornice nazionale che individua tre figure professionali distinte, non una figura singola. Rispetto a entrambi i Volumi precedenti, questa figura dispone di un'evidenza di efficacia di livello Cochrane — sebbene limitata alla sola demenza e con conclusioni cautelative — laddove Counselor e Mediatore Familiare non disponevano di alcuna revisione sistematica Cochrane o Campbell. Per la parte in cui il responsabile di progetto TAA sia un medico o uno psicologo, questo Volume rinvia all'opera madre «Psicologo di Base» e ai Volumi pertinenti della collana gemella «Le Professioni di Base», senza duplicarne la valutazione.

Appendice D. Architettura budget-impact

Non popolata in questa tranche. L'assenza di un conteggio nazionale di operatori e strutture, di un dato di utilizzo per popolazione target, e di qualunque studio di costo-efficacia rispetto alla cura standard impedisce la costruzione di un modello di budget-impact parametrico affidabile. Il dato di finanziamento pubblico dell'Emilia-Romagna potrebbe costituire un punto di partenza per un futuro modello regionale, non nazionale.

Appendice E. Tabella GRADE

Evidenza sulla terapia assistita con animali nella demenza: qualità da bassa a molto bassa sulla maggior parte degli esiti, secondo la revisione Cochrane 2019 (CD013243). Evidenza per disturbo dello spettro autistico, disturbo da stress post-traumatico e depressione: qualità inferiore, nessuna revisione Cochrane disponibile. Evidenza sull'intelligenza artificiale applicata agli Interventi Assistiti con gli Animali: qualità non valutabile per assenza pressoché totale di letteratura pertinente, distinta da un'assenza «preliminare» e più vicina a un'assenza integrale. Le due basi evidenziali sono trattate con lo stesso rigore, in una condizione di simmetria dichiarata che in questo caso registra un'asimmetria reale a sfavore della componente di intelligenza artificiale.

Appendice F. Blocchi-prompt infografiche

Infografica 1: le tre figure professionali IAA e il percorso formativo comune (propedeutico, base, avanzato). Infografica 2: cronologia dell'attuazione regionale 2015-2024, con evidenza del divario tra Lazio (2016) e Veneto (2024). Infografica 3: sintesi grafica della revisione Cochrane 2019 sulla demenza, con marcatura esplicita del livello di qualità dell'evidenza per ciascun esito misurato.

Appendice G. Nota editoriale e lacune dichiarate

Questo Volume dichiara le seguenti lacune informative non colmabili nella presente tranche: mancata consultazione diretta del testo integrale dell'Accordo Stato-Regioni 25 marzo 2015 e delle relazioni annuali del Centro di Referenza Nazionale IAA, per un blocco tecnico sistematico dello strumento di recupero diretto delle pagine web; assenza di un conteggio nazionale certificato di operatori e strutture accreditate; ipotesi iniziale della ricerca relativa a un ente «SIAA» non confermata e non ripresa nel Volume; relazione esatta tra la norma UNI 11790:2020 e le figure IAA non verificata; assenza di un dato nazionale di utilizzo per popolazione target; assenza di qualunque studio italiano o internazionale di costo-efficacia dell'intervento assistito dagli animali rispetto alla cura standard.